

肺ノカルジア症への対処

サイトメガロウイルス肺炎、肺アスペルギルス症・肺カンジダ症・肺クリプトコックス症（真菌症の項を参照）、肺抗酸菌感染症、ニューモシスチス肺炎、肺ムーコル症に関しては、別に解説されているので各項を参照のこと。以下では重要な原因菌であるノカルジアについて解説する。肺ノカルジア症は、細胞性免疫不全が低下している患者で発症する日和見感染症である。

i) 細菌学的特徴

ノカルジアは土壤中に広く分布する Gram 陽性の好気性放線菌群である。分枝状の形態から真菌と考えられていたが、分子生物学的には細菌（放線菌属）に分類される。

ii) 症候・身体所見

発熱・咳嗽・痰・胸膜痛・全身倦怠感など。

iii) 診断・検査

画像所見は、区域性の浸潤影が主、結節影、空洞形成、胸水貯留、粟粒陰影など多彩である。血行性に脳膿瘍を合併することがある。特異的な血清学的診断法はなく、病変部位から菌を検出・同定することが必須である。Gram 染色では分枝状の Gram 陽性桿菌という特徴的な像を呈するが、一般細菌よりも発育が遅く 5～21 日近くを要する。Ziehl-Neelsen 染色（Kin-youn 変法）でも染色される¹⁾。菌種や菌株により感

受性を有する薬剤が異なるため、薬剤感受性試験の実施が強く推奨されている。

iv) 治療

エンピリック治療としては、sulfamethoxazole/trimethoprim 合剤が第一選択となる。ノカルジア感染症に対する薬物治療の比較試験が存在しないため肺以外の感染部位や重症度を考慮して amikacin や imipenem などとの併用療法も検討する必要がある。至適な治療期間は明確ではないが、6～12 ヶ月の治療、特に免疫不全者や中枢神経病変を伴う場合には最低 12 ヶ月の治療が勧められている。治療終了後も再燃の可能性があり、経過観察が必要である。

Advanced

■新規治療薬による日和見感染症の増加

TNF- α 阻害薬をはじめとする生物学的製剤治療の普及に伴い、その有害事象としての感染症の増加、特に抗酸菌感染症やニューモシスチス肺炎が問題となっている。HIV 感染症の場合と異なり、CD4 リンパ球数などの免疫不全の指標は必ずしも低下しない。結核では全身播種型（粟粒結核）が多い。

文 献

- 1) 大曲貴夫ほか：免疫不全者の呼吸器感染症，南山堂，p26, 166, 2011